

Neurologiska- & reumatologiska sjukdomar - Caseseminarium

MV037G Vård vid ohälsa och sjukdom

Elin Nyberg, universitetsadjunkt

Lärandemål

- Mål 1: Beskriva och förklara **vanligt förekommande sjukdomstillstånd** gällande **orsak, symtom och diagnos** samt **beskriva relevanta evidensbaserade behandlingsmetoder**
- Mål 2: **Identifiera vård- och omvårdnadsbehov** hos patienter i relation till specifika sjukdomstillstånd samt utifrån ett kritiskt förhållningssätt **beskriva och motivera relevanta evidensbaserade åtgärder**
- Mål 3: Beskriva och förklara **farmakologiska behandlingar, förväntade och oönskade läkemedelseffekter** samt **sjuksköterskans ansvar i samband med farmakologisk behandling**
- Mål 5: Relatera till **relevanta författningar**

Praktiska detaljer & dagens upplägg

- Del 1: Gemensam introduktion
- Del 2: Arbete i grupper med fallbeskrivningar
 - 1 fall per grupp.
 - Skriv ner era svar och maila till (läggs sedan ut på Canvas):
elin.nyberg@miun.se
- Del 3: Gemensam genomgång/diskussion av 2 fall
- Del 3: Arbete med tentamensfrågor i grupp



Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

Avgränsning

- **Neurologiska sjukdomar** = Samlingsnamn för medicinska sjukdomar som påverkar kroppens nervsystem.

- Multipel skleros (MS)
- Parkinsons sjukdom
- Epilepsi (EP)

- **Reumatologiska sjukdomar** = Samlingsnamn för medicinska sjukdomar som påverkar rörelseorganen och stödjevävnaderna (leder, senor, muskler och skelett). Men även hud och inre organ drabbas.



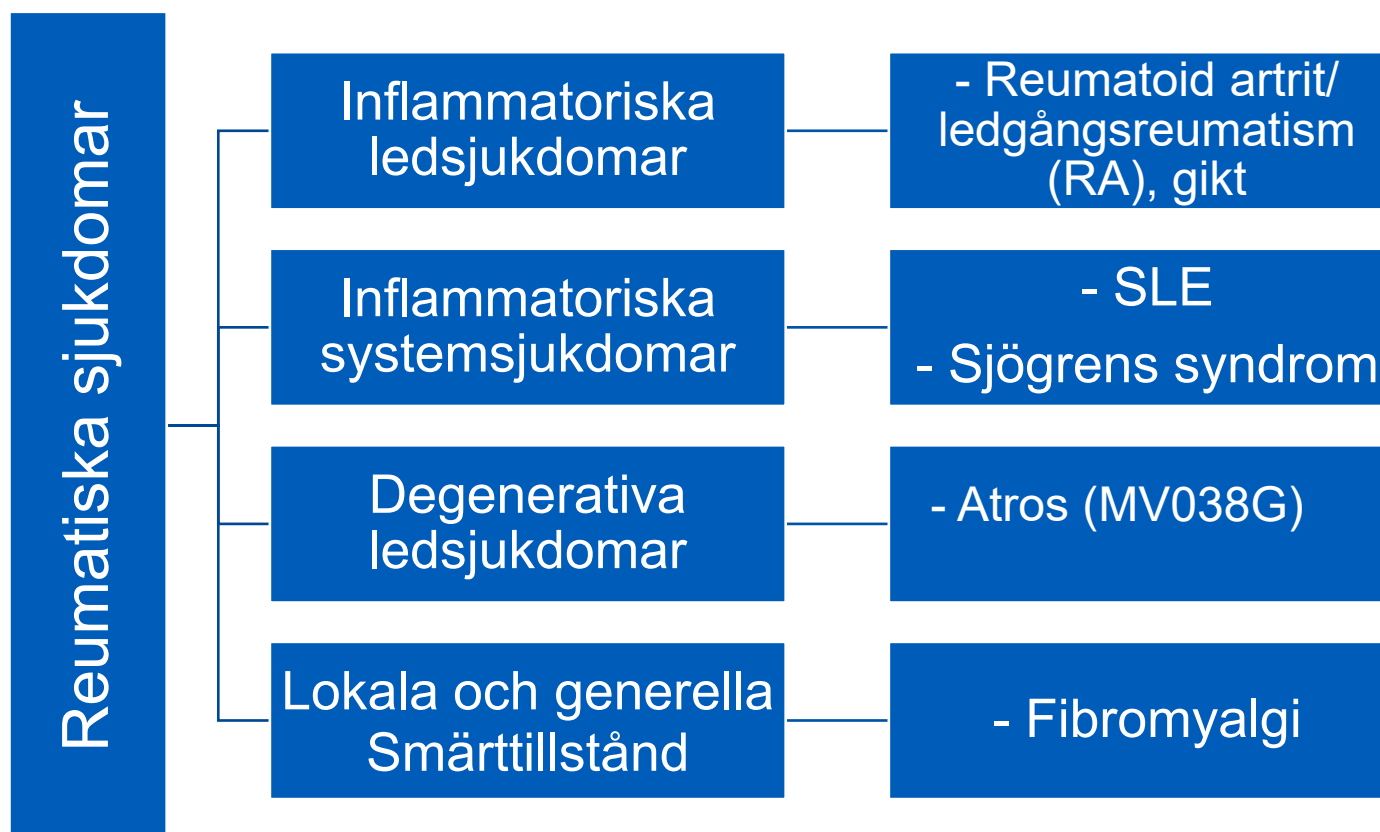
- Reumatoid artrit (RA)
- Gikt
- Sjögrens syndrom
- Fibromyalgi

Reumatologiska sjukdomar & diagnosgrupper

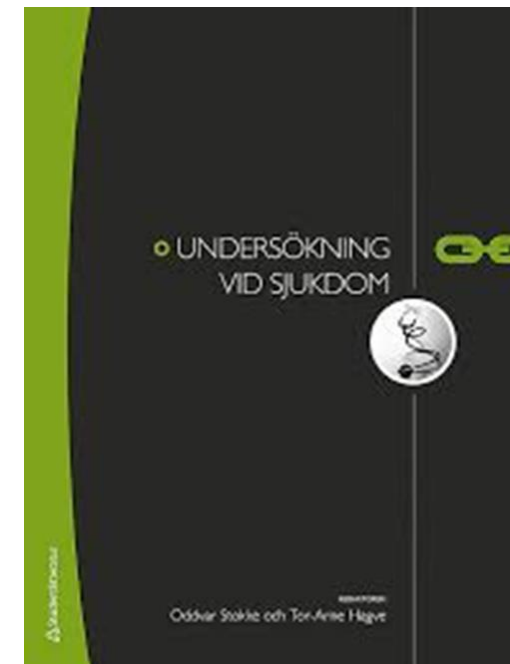
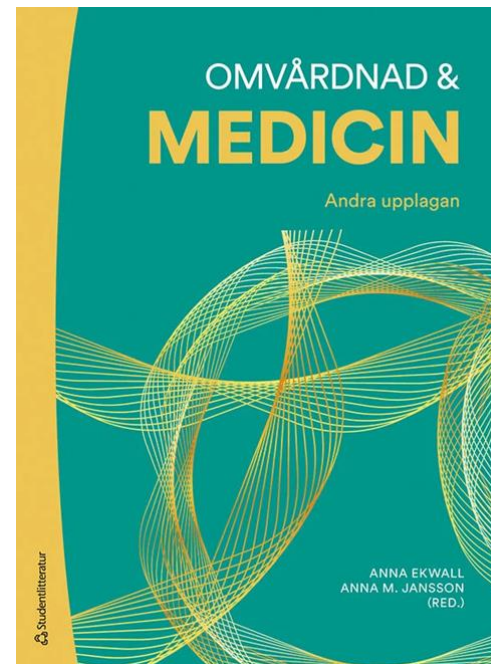
De flesta reumatiska sjukdomarna är:

- Inflammatoriska
- autoimmuna

Som sjukdomsgrupp –
**vanligt
förekommande**



Litteratur



Gruppindelning

Grupp 1 - fallbeskrivning 1 om RA

Grupp 2 – fallbeskrivning 2 om Sjögrens syndrom

Grupp 3 – fallbeskrivning 3 om Gikt

Grupp 4 – fallbeskrivning 4 om Fibromyalgi

Grupp 5 – fallbeskrivning 5 om Parkinson

Grupp 6 – fallbeskrivning 6 om MS

Grupp 7 – fallbeskrivning 7 & 8 om Epilepsi

- Tid för återsamling

Gemensam genomgång

Fallbeskrivningar RA & Parkinson

Fall 1 - RA

Fall 1 – RA

Fråga 1:

Vilka symtom i fallbeskrivningen om Anna-Lena tyder på att hon har drabbats av RA? Redogör också för andra typiska symtom som ofta förekommer vid reumatoid artrit.



Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt [CC BY-SA](#)

Reumatoid artrit/ kronisk ledgångsreumatism (RA) – symtom

- Svullna, ömmande och stela småleder i händer & fötter
 - Värre av inaktivitet. Ofta mest besvär på morgonen.
- Sjukdomskänsla
- I början ofta skov → kontinuerliga symtom
- Större leder (vid mer framskriden sjukdom)
- Ibland sk extraartikulära manifestationer
 - Reumatiska knutor
 - Pleurit
 - Perikardit
 - Reumatisk lunginflammation
 - Vasulit

Ni behöver inte kunna dessa i detalj mer än veta att RA ibland också drabbar andra strukturer än leder.

Fall 1 – RA

Fråga 2: Vid RA drabbas ledhinnan. Vad är ledhinnan, och förklara vad som sker med den vid RA. Redogör även för de patofysiologiska processer som leder till de symtom som uppstår vid sjukdomen.

Reumatoid artrit/ kronisk ledgångsreumatism (RA) – patofysiologi & orsaker

- Ledhinna/synovialledhinna = klär insidan av lederna.
- Autoimmun sjukdom
- Ledhinnan inflammeras
- Autoantikroppar: ACPA, RF
- Inflammationen skadar så småningom underliggande brosk och ben liksom kringliggande strukturer.

Fall 1 – RA

- **Beskriv orsaker till RA? Finns det några riskfaktorer för RA hos Anna-Lena?**

Reumatoid artrit/ kronisk ledgångsreumatism (RA) – orsaker

- Orsaken är oklar. Sannolikt samverkar en mängd olika faktorer.
 - Genetiska faktorer
 - Omgivningsfaktorer. Rökning mest studerade,
- Vanligare bland kvinnor. Medianålder för insjuknande är 55-60 år

Riskfaktorer hos Anna-Lena är att hennes **mamma har RA (gener)** och att hon är **rökare**. Sjukdomen är 2-3 ggr vanligare bland **kvinnor**. **Åldern**

Fall 1 – RA

- **Förklara vad det är för blodprover Anna-Lena tagit och innebörden av hennes provsvar i relation till referensvärden?**
- **Hur ställs diagnosen vid RA?**

Reumatoid artrit/ kronisk ledgångsreumatism (RA) – utredning och diagnos

- Kriteriebaserad diagnos. Se tabell på sida 432 i Omvårdnad och Medicin.

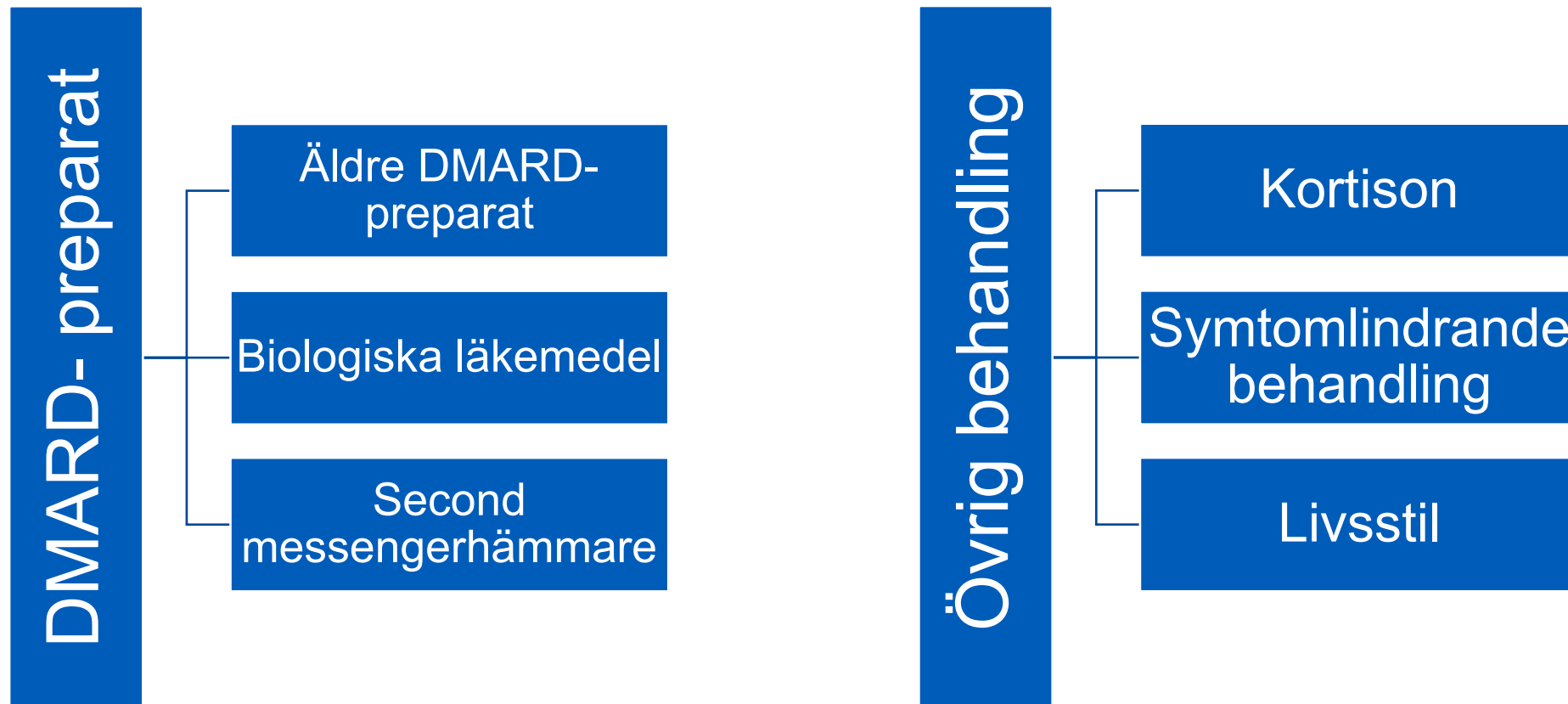
Blodproverna är diagnostiska hjälpmedel. Kriterierna betonar i övrigt att ha många drabbade leder och sjukdomsduration.

- sänka på 45 - förhöjd
- CRP på 28 - förhöjd
- förekomst i blodet av anti-citrullinerad peptid antikroppar (ACPA) och positiv reumatoidfaktor (RF).
 - Blodprovet för anti-CCP mäter nivåerna av antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA) i blodet.
 - Autoantikroppar (antikroppar som riktar sig mot kroppsegna strukturer) vid RA

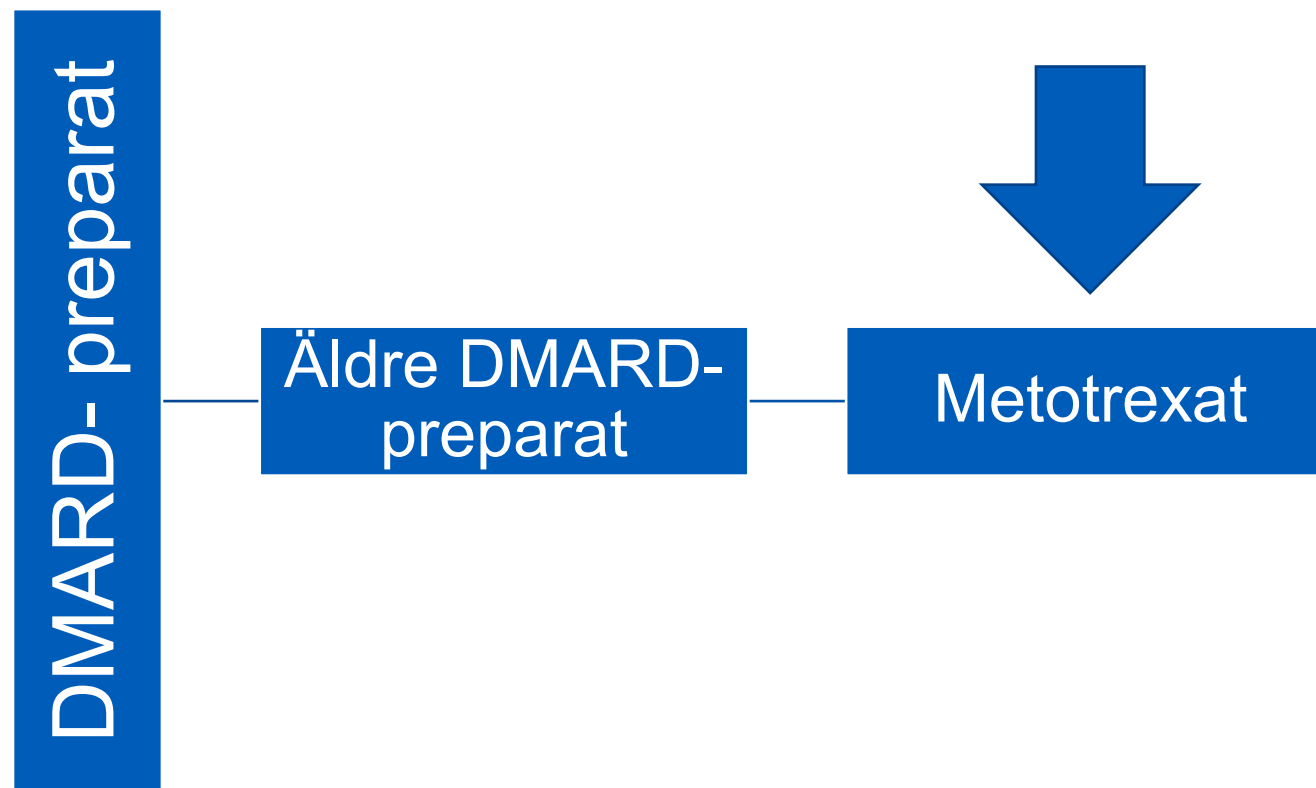
Fall 1 – RA

- **Efter att diagnosen fastställs sätts Anna-Lena in på Metotrexat, Folacin och Prednisolon.**
 - **Vad är Metotrexat för läkemedel och hur verkar detta? Vad innebär upptrappande dos? Vilka vanliga biverkningar finns med Metotrexat?**
 - **Vad är Folacin? Varför ordineras Anna- Lena Folacin och varför tas detta läkemedel just på dessa dagar?**

Reumatoid artrit/ kronisk ledgångsreumatism (RA) – kort översikt av behandling



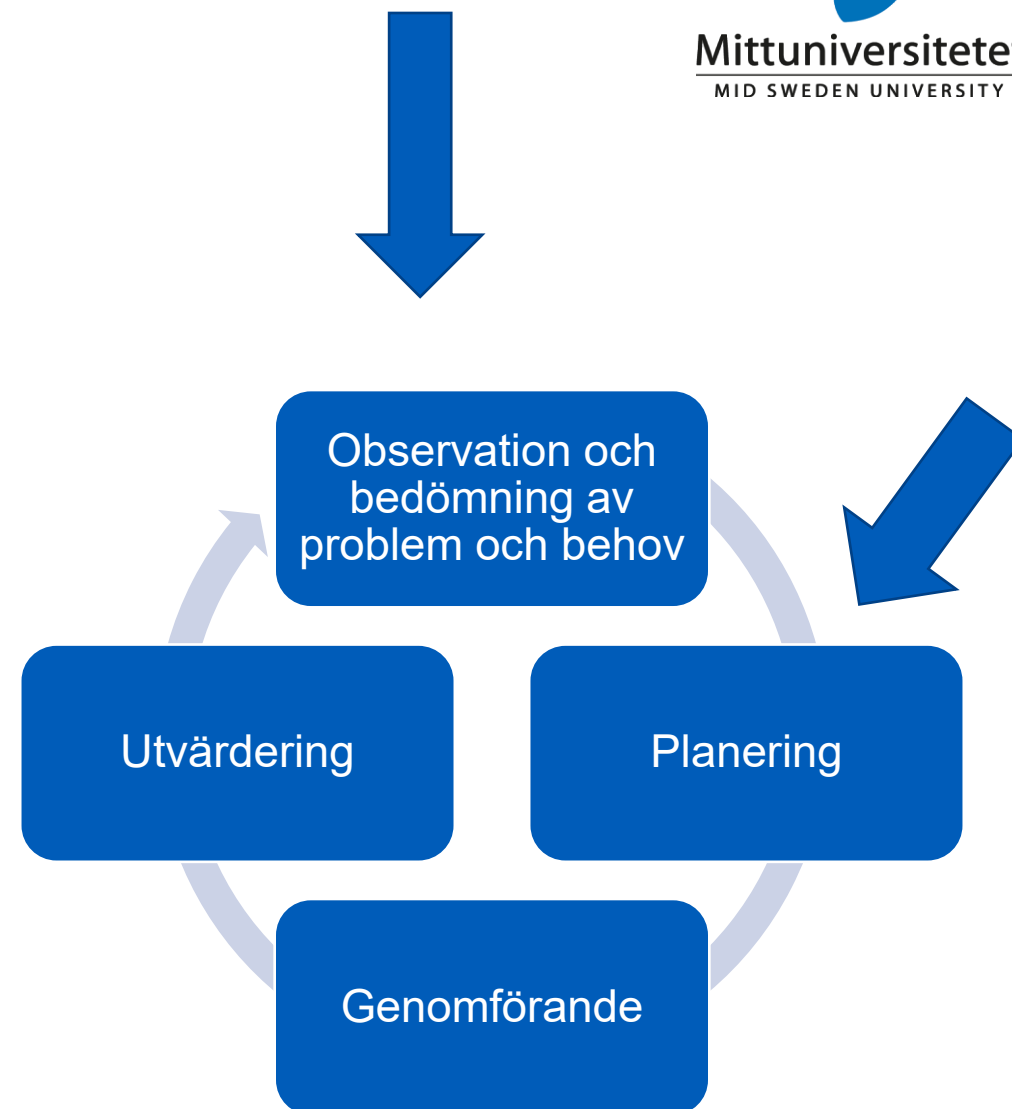
Reumatoid artrit/ kronisk ledgångsreumatism (RA) – behandling



- Folsyraantagonist. Detta hämmar immunförsvaret och minskar inflammationen.
- Biverkningar: Illamående, blåsor och irritation av munslemhinnan, leverpåverkan, anemi, leukopeni, trombocytopeni, lungpåverkan.
- Kombineras med folsyra (ett B-vitamin) för minskade biverkningar
- Lungröntgen & blodprover behöver följas
- Tas en gång i veckan. Tablett eller s.c injektion.

Fall 1 – RA

- **Vilka möjliga omvårdnadsproblem och behov hittar du i fallbeskrivningen med Anna-Lena?**
- **Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Anna-Lenas omvårdnadsproblem?**



Omvårdnadsproblem / behov (7)

Smärta, stelhet och nedsatt ledfunktion

Fatigue/trötthet och störd nattsömn

Risk för undernäring relaterat till viktninskning och nedsatt aptit

Oro och nedstämdhet kopplat till diagnos

Social isolering och minskad aktivitet

Behov av multiprofessionellt stöd

Oberoende omvårdnadsåtgärder (8)

Information om icke-farmakologiska behandlingsalternativ. Patientundervisning om smärta, smärtmekanismer och smärtlindring. Användning av värme/kyla, avspänningstekniker, anpassad träning (i samverkan med fysioterapeut). Avlastning med stödbandage/ortoser. Tillämpning av TENS, akupunktur och paraffinbad.

Ge sömnråd och stöd i energibesparande strategier. Planering av dagliga aktiviteter med balans mellan vila och aktivitet.

Uppföljning av vikt och nutritionsstatus. Genomföra nutritionsbedömning och ge individanpassade kostråd. Samverkan med dietist vid behov.

Erbjuda stödjande samtal och motiverande samtal. Ge kontinuerlig information om sjukdom och behandling.

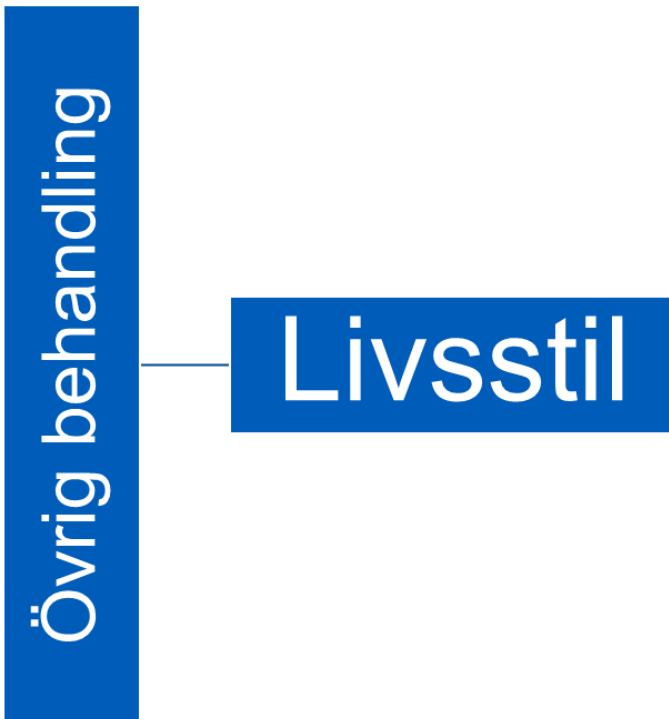
Uppmuntra sociala kontakter och deltagande i stödgrupper. Stödja delaktighet i aktiviteter utifrån förmåga. Patientundervisning om fysisk aktivitet och dess hälsoeffekter.

Samverkan med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator för ett helhetsperspektiv på vården.

Se tabell 14.4 på sida 448 i Omvårdnad & medicin

Fall 1 – RA

- Vad svarar du Anna-Lena gällande hennes frågor om kost och träning?



<https://www.gu.se/forskning/kost-vid-kroniska-inflammatoriska-sjukdomar>

Fall 1 - RA

- **Varför behöver Anna-Lena ta prover regelbundet och vilka är de vanligaste rutinproverna för monitorering av antireumatiska behandlingar?**
- Pga behandling med Metotrexat.
 - Sänka och CRP
 - Blodstatus
 - Leverprover
 - Njurprover

Fall 1 – RA

- **Varför är det viktigt för Anna-Lena att sluta röka? Svara både specifikt utifrån hennes RA-diagnos men även mer generella vinster av att sluta röka.**
 - Ökad risk för hjärt- kärlsjukdom
 - Aggressivare sjukdomsförlopp
 - Minskad effekt av många RA-läkemedel.



[Det här fotot](#) av Okänd författare licensieras enligt [CC BY-NC-ND](#)

Fall 5 – Parkinson

Fall 5 – Parkinson

Vilka symtom på Parkinson hittar du i fallbeskrivningen om Anna? Vilka andra typiska symtom finns vid Parkinson?

- axelbesvär
- problem med handstil
- distriktsläkaren noterat kugghjulsfenomenet i handleden.
- i några år haft sämre luktsinne
- börjat prata i sömnen det senaste året
- Trög magen

Parkinsons sjukdom - symtom

- **Tremor** = skakningar
- **Bradykinesi** = Motorisk
förlångsamning, rörelsehämning
- **Rigiditet** = muskelstelhet.
- **Autonoma symtom**
- **Fatigue, smärta & sömnrubbningar,
psykiska symtom**

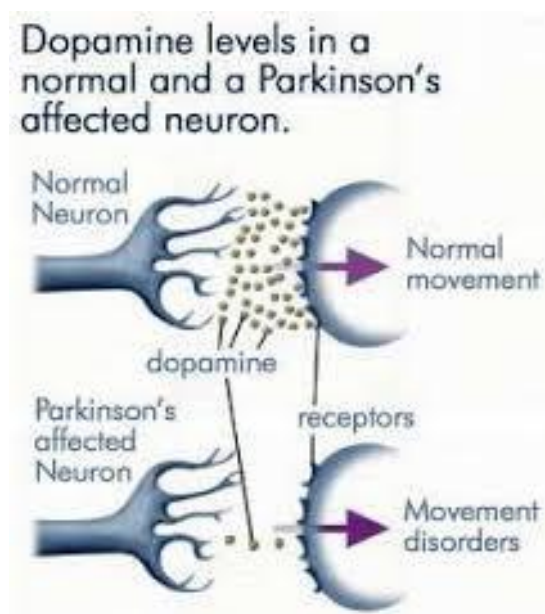
Symtomtriaden

Fall 5 - Parkinson

Förklara vad som sker i kroppen vid Parkinson? (patofysiologi)

Beskriv orsaker till Parkinson? Finns det några riskfaktorer för Parkinson hos Anna?

Parkinsons sjukdom - patofysiologi & orsaker



Okänd orsak. Ålder främst riskfaktorn. Ärftlig komponent, miljöfaktorer, tarmflora. Metabola syndromet.

- **Lewy bodies- plack förstör dopaminproducerande nervceller i substantia nigra i hjärnstammen**
-  **dopaminförlust i basala ganglierna**
- Dopaminförlust i basala ganglierna ger **upphov till de karakteristiska symtomen.**

Fall 5 – Parkinson

Anna ordineras Madopark, vad är detta för typ av läkemedel och hur verkar det? Redogör även för vanliga biverkningar och vilken information Anna behöver få kring läkemedlet för att behandlingen ska fungera så bra som möjligt?

Parkinsons sjukdom - behandling

Finns ingen botande behandling

- Läkemedelsbehandling i tre steg
 - **Levodopa (alt duodopa)**
 - Dopaminagonister
 - Minska nedbrytningen av dopamin och levodopa

Levodopa = L-dopa är ett förstadium till dopamin och det kan passera blod-hjärnbarriären. I hjärnan omvandlas L-dopa sedan till dopamin.

- Kort halveringstid. Måste tas på fasta tider och ½-1 timme före måltid för bra upptag. Gärna i sängen på morgonen.
- Upptaget kan minska om man tar den tillsammans med proteinrikkost (L-dopa är en aminosyra) .
- Biverkningar: Ortostatisk hypotoni, ödem, mentala förändringar, illamående, huvudvärk.
- Kombinerar ofta med läkemedel som hämmar nedbrytningen av L-dopa

Fall 5 – Parkinson

Hur ställer läkaren Annas diagnos?

Parkinsons sjukdom - diagnos

- Klinisk undersökningar, anamnes
- Medicineringen är ofta en del av diagnostiken
- Kan användas vid behov: DAT-scan & "SPECT"

Fall 5 - Parkinson

Vilka omvårdnadsproblem hittar du i fallbeskrivningen med Anna?

Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Annas omvårdnadsproblem?

OMVÅRDNADSPROBLEM/ BEHOV	OBEROENDE OMVÅRDNADSÅTGÄRDER
Fatigue/trötthet	Planera dagliga aktiviteter med återhämtningspauser. Prioritera uppgifter, använda energibesparande strategier. Regelbunden sömn och dygnsrytm
Förstoppning	Fiberrik kost och tillräckligt vätskeintag. Regelbunden fysisk aktivitet. Skapa regelbundna toalettvanor
Psykosociala problem: oro, påverkan på livskvalitet	Ge möjlighet till samtal och stöd. Informera om patientföreningar. Uppmuntra delaktighet i sociala aktiviteter

Fall 5 – Parkinson

Vad innebär dosglapp och fluktuationer?

Dosglapp = Effekten av varje L-dopa dos blir kortare med luckor i läkemedelseffekt

Fluktuationer = Växlingar mellan god effekt och otillräcklig effekt

Fall 2 – Sjögrens syndrom

Fall 2 – Sjögrens syndrom

- **Vilka symtom hittar du i fallbeskrivningen om Emma som tyder på att det är Sjögrens syndrom hon drabbats av?**

Sjögrens syndrom – symtom

- Mun- och ögontorrhet
- Problem med munhälsan: karies och svampinfektioner
- Torr hud
- Torr näsa
- Torrt svalg med sväljsvårigheter
- Torra luftrör med torrhosta
- Torrt underliv
- Trötthet
- Ca 1/3 får engagemang av andra organ i sjukdomen som inflammation i leder, kärl, lungor, nerver och njurar.
 - Sämre cirkulation i händer och fötter
 - Magbesvär
 - Ledsmärta

Fall 2 – Sjögrens syndrom

- **Vid Sjögrens syndrom drabbas kroppens exokrina körtlar, vad är exokrina körtlar och vilken funktion har dom? Förklara också vad som sker med dessa körtlar vid Sjögrens syndrom och vad som händer i kroppen som ger symtomen vid sjukdomen (patofysiologi).**

Sjögrens syndrom – patofysiologi

- Autoimmun sjukdom
- Drabbar exokrina körtlar.
Inflammation.
- Överaktivitet hos de antikroppsbildande B-lymfocyter och en överproduktion av olika typer av antikroppar.
- Primärt Sjögrens syndrom:
Patienten lider ej av någon annan autoimmun reumatisk sjukdom.
- Sekundärt Sjögrens syndrom:
Patienten har samtidigt en annan autoimmun reumatisk sjukdom (till exempel RA, SLE).

Sjögrens syndrom – orsaker & diagnos

- **Förklara vad det är för blodprover Emma tagit och innebörden av hennes provsvar i relation till referensvärden?**
- **Emma får genomföra schirmertest, sialometritest och en spottkörtelbiopsi. Vad är detta för undersökningar och vad har de för betydelse för att ställa diagnos?**
- SR & CRP förhöjda
- Anti-SSA, anti-SSB (autoantikroppar – ej sjukdomsspecifika) positiva
- Schirmertest: tårvätskemätning
- Sialometritest: salivsekretionsmätning
- Spottkörtelbiopsi

Se kriterier i omvårdnad & medicin sida 458

Fall 2 – Sjögrens syndrom

- Vilka omvårdnadsproblem hittar du i fallbeskrivningen med Emma?
- Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Emma omvårdnadsproblem?
- Emma ordineras hydroxyklorokintabletter, vad är detta för typ av läkemedel och varför ordineras Emma detta läkemedel?
- Trötthet
- Ögontorrhet
- Muntorrhet
- Torra slemhinnor i underlivet och påverkar sexliv
- Hydroxiklorokin är ett DMART-preparat. Inflammationsdämpande.

Fall 3 – Gikt

Gikt – symtom

- **Vilka symtom hittar du i fallbeskrivningen om Ove som tyder på att det är gikt han drabbats av?**
- Ömmande, rodnad och svullen led i stortån

Övriga vanliga symtom:

- (även andra leder kan drabbas men stortån är vanligast)
- Sjukdomskänsla och feber

Fall 2 – Gikt

- **Förklara också vad som sker i kroppen och ger dessa symtom vid gikt (patofysiologi).**
- **Beskriv orsaker till gikt? Finns det några riskfaktorer för gikt hos Ove?**
- **Förklara vad det är för blodprov Ove tagit och innebörden av provsvaret i relation till referensvärden?**

Gikt – patofysiologi & orsaker + riskfaktorer

- Utfällning av urat (urinsyra) i lederna. Uratet bildar kristaller i leden som i sin tur orsaker en inflammation i leden. Ger ökat CRP.
- Urat är en nedbrytningsprodukt av puriner. Hög halt av urinsyra = ökad risk för gikt.
- Vart finns puriner?
 - I våra celler. Puriner läcker ut vid celldöd.
 - Kost: tas upp ur kosten
- **Ålder**: ökar med stigande ålder
- Vanligare hos **män**
- Gener
- **Alkohol**
- Purinrik mat (inälvsmat, makrill, sill)
- **Övervikt**
- Vissa läkemedel ger ökad mängd urinsyra i blodet. **Hydroklortiazid är ett exempel.**

Gikt – behandling

Ove ordineras Diklofenak, vad är detta för typ av läkemedel och varför ordineras Ove detta läkemedel?

Beskriv även verkningsmekanismen och biverkningar.

- NSAID
 - Inflammationsdämpande och smärtstillande
 - Utövar effekt genom att hämma enzymet COX som bildar prostaglandiner = minskad mängd prostaglandiner
 - Biverkning: Magbesvär. Ökad risk för magsår. Ökad risk för hjärt-kärl sjukdom

Fall 3 – diagnos

Hur ställs diagnosen vid gikt?

Ledvätska dras ut med spruta ur den drabbade leden och uratkristaller påvisas i denna.

Fall 3 – Gikt

Varför är det viktigt för Ove drar ner på sin alkoholkonsumtion och att gå ner i vikt? Svara både specifikt utifrån hans gikt-diagnos men även mer generella vinster ni känner till.

Vad innebär ett hälsosamtal? Vad tänker ni är viktigt att prata om med Ove på detta samtal?

Fall 4 – Fibromyalgi

Fall 4 – fibromyalgi

Vilka symtom hittar du i fallbeskrivningen om Maria som tyder på att det är fibromyalgi hon drabbats av? Vilka andra typiska symtom finns vid fibromyalgi?

- Långvarig smärta
- Trötthet
- Störd sömn
- Mag- tarmbesvär
- Ångest & depression

Fall 4 – fibromyalgi

Förklara vad som händer i kroppen vid sjukdomen (patofysiologi) som ger symtomen vid sjukdomen

- Ökad känslighet i smärtnervsystemet
 - Perifera nerver reagerar med smärtimpulser på normalt icke-smärtsamma stimuli
 - Nerver i CNS förstärker perifera smärtimpulser
- Sänkt smärthämmande bansystem

Beskriv orsaker till fibromyalgi? Finns det några riskfaktorer för fibromyalgi hos Maria?

- Orsaken till stor del okänd.
- Ny forskning har visat att CNS immunceller, sk gliaceller, är aktiverade i hjärnan.
<https://urplay.se/program/233570-sverige-forskar-sa-ger-fibromyalgi-smarta>

<https://nyheter.ki.se/personer-med-fibromyalgi-har-inflammation-i-hjarnan>

Fall 4 – Fibromyalgi

Förklara vad det är för blodprover
Maria tagit och innebörden av hennes
provsvär i relation till referensvärden?

*HB, CRP, Trombocyter och
Leukocyter är normala (inom
referensvärden)*

Hur ställer läkaren diagnosen vid
fibromyalgi?

- Minst 3 mån
- 4 kroppskvadranter, 11 av 18
triggerpunkter

Fall 4 – fibromyalgi

Finns det någon behandling som ni tror läkaren kommer ordinera?

Vilka omvårdnadsproblem hittar du i fallbeskrivningen med Maria?

Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Emma omvårdnadsproblem?

Fall 6 – MS

Fall 6 – MS

Vilka symtom hittar du i fallbeskrivningen om Malin som tyder på att det är MS hon drabbats av? Vilka andra typiska symtom finns vid MS?

- Domning av vänster fot och ben, upp till navelnivå.
- Svårt att gå
- Svårt att tömma blåsan

Multipel skleros – symtom & konsekvenser

- Beroende av vilken del av hjärna eller ryggmärg som påverkats varierar symtomen. Vanliga symtom:
 - Sensoriska symtom som domningar och dålig djupkänsl
 - Synproblem
 - Balansproblem, koordinationsproblem, svårt att gå
 - Spasticitet
 - Nedsatt talförmåga
 - Humörsvängningar
 - Nedsatt minne och koncentration
 - Nedsatt livskvalitet & depression
 - Svår trötthet och fysisk utmattning
 - Sexuell dysfunktion
 - Störd kontroll av blåsa och tarm
 - Reducerad muskelstyrka och förlamningar
 - Smärta

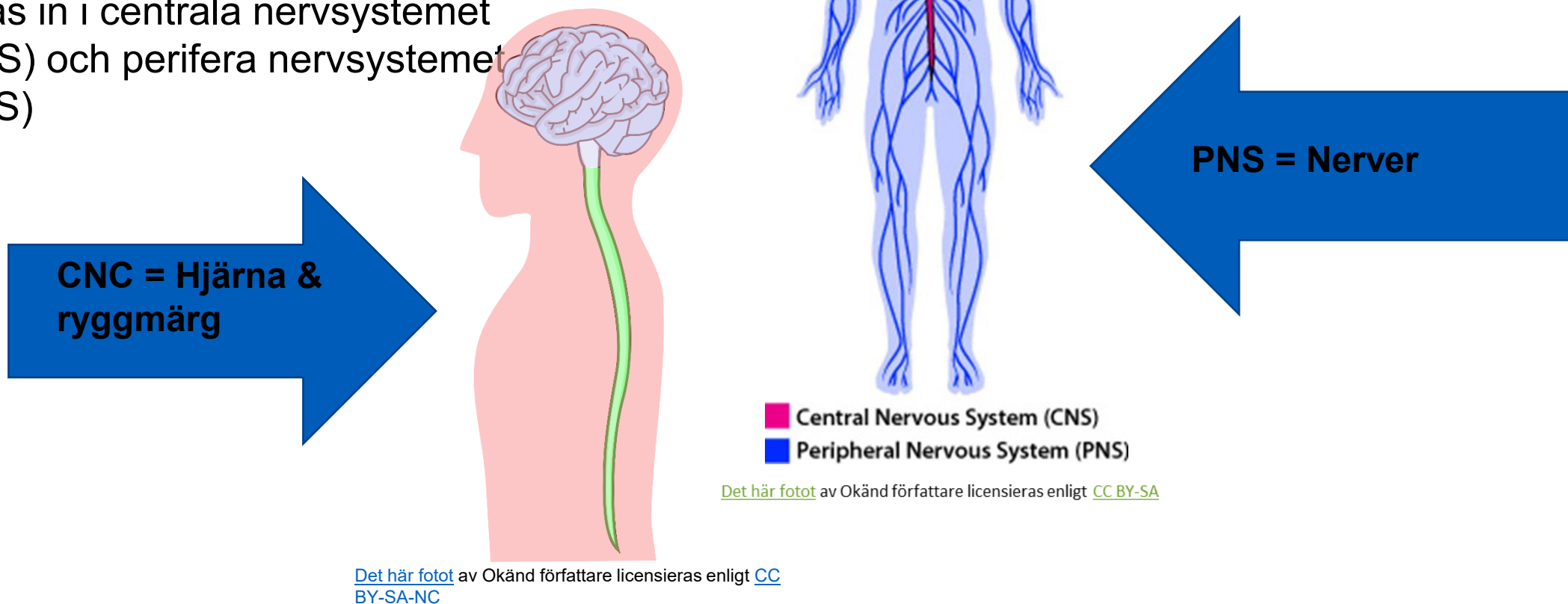
Fall 6 - MS

MS är en sjukdom som drabbar myelinet på nerver i det centrala nervsystemet, CNS. Förklara vad myelin och CNS är och beskriv vad som vad som händer i kroppen vid MS och hur det kan förklara symtomen som uppstår?
(patofysiologi)

Beskriv orsaker till MS? Finns det några riskfaktorer för MS hos Malin?

Nervsystemet

Delas in i centrala nervsystemet (CNS) och perifera nervsystemet (PNS)



Multipel skleros – patofysiologi

- Kronisk inflammatorisk sjukdom i CNS
- Demyelisering av axoner
- Inflammationer
- Skleroser

Multipel skleros – orsaker och riskfaktorer

- **Orsaker:** komplext samspel mellan arvsanlag och omgivnings- och livsstilsfaktorer (infektioner, rökning, låga nivåer av D-vitamin, övervikt i unga år)
- **Drabbar främst kvinnor mellan 20-45 år**

/

Fall 6 – MS

Förklara vilka undersökningar läkaren har använt sig för att fastställa diagnosen och vad som krävs för att kunna ställa diagnosen MS?

- CT
- MR
- Lumbalpunktion

Multipl skleros – diagnos

- Anamnes
 - Neurologisk undersökning
 - MR
 - Lumbalpunktion
-
- McDonald kriterier
 - För att ställa diagnosen behöver man kunna påvisa spridning i det centrala nervsystemet i tid och rum

Fall 6 – MS

Malin ordineras primärt SoluMedrol, vad är detta för typ av läkemedel och varför ordineras Malin detta läkemedel? Beskriv även verkningsmekanismen och biverkningar.

Förklara vad sjukdomsmodifierande behandling innebär?

- Solumedrol = kortison som ges vid akut skov. Dämpar inflammationen och är därmed symtomlindrande.

Multipl skleros – behandling

Finns ingen botande
behandling

Behandlingsmål:

- reducera skovens varaktighet
& frekvens
- förebygga en progressiv
utveckling av sjukdomen

- Sjukdomsmodifierande
behandling
- Symtomatisk behandling
 - Vid skov
 - Smärta
 - Blåstömningssproblem
 - Psykiska problem



Fall 6 - MS

Vilka omvårdnadsproblem hittar du i fallbeskrivningen med Malin?

Vilka oberoende omvårdnadsåtgärder kan vara aktuella utifrån Malins omvårdnadsproblem?

Fall 7 & 8 – Epilepsi

Fall 7 – Epilepsi

Vilka symtom på epilepsi hittar du i fallbeskrivningen om Karl?

Anfallsbeskrivningen för tankarna till att Karls typ av anfall är fokala anfall. Vad innebär det och vad skiljer fokala anfall från generaliserade anfall?

Epilepsi – symtom & klassificering av anfall

- Exempel på symtom:
 - allt från små muskelryckningar till större muskelryckningar
 - Ofrivilliga rörelser
 - Medvetandepåverkan
 - Urinavgång
- Förkänning/aura
- Postiktalitet



Fokala



Generaliserade

Generaliserat
tonisk-kloniskt
anfall



Okänd anfallstyp

Fall 7 – Epilepsi

Förklara vad som händer i kroppen
vid epilepsi? (patofysiologi)

Beskriv orsaker till Epilepsi?

Epilepsi – patofysiologi

- Ett samlingsnamn på olika tillstånd som innebär en varaktig benägenhet att få **oprovocerade epileptiska anfall. Dvs** anfall som inte framkallats av en övergående yttre orsak

Vad är epileptiskt anfall?

- Okontrollerad aktivitet i nätverk av hjärnceller. Olika uttryck.

Epilepsi – orsaker

- Många orsaker:
 - skador som uppstått i fosterlivet, förlossningsskador, medfödda neurologiska hjärnsjukdomar, genetiska orsaker, skallskador, hjärntumörer, cerebrovaskulära sjukdomar, neurodegenerativa tillstånd.

Anfallsutlösande orsaker: sömnbrist, stress, andra känslomässiga påfrestningar samt glömd läkemedelos.



Fall 7 – Epilepsi

Karl genomför EEG och MR. Vad är detta för typ av undersökningar och varför görs dessa på Kars?

Hur ställer läkaren Karls diagnos?

Epilepsi – diagnos

- Anamnes
- Neurologisk undersökning
- MR
- EEG

Fall 7 – Epilepsi

Karl ges information om vilka högriskaktiviteter han bör avstå, vad innefattar denna information?

Epilepsi – konsekvenser

- Otrygghet
 - Depression
 - Möjlighet att ta körkort och yrkesval
 - Begränsningar & isolering
 - Risk för skador
 - Minnesproblem
 - Trötthet
- Kan vara livshotande (status epilepticus)

Epilepsi är så mycket mer än själva anfällen

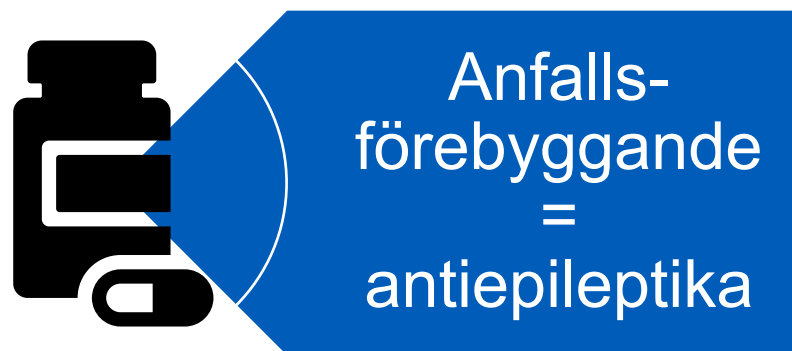
Fall 7 – Epilspsi

Karl ordineras lamotrigin, vad är detta för typ av läkemedel och varför ordinerar Karl detta läkemedel? Beskriv även verkningsmekanismen och biverkningar.

Epilepsi behandling



Epilepsi – behandling



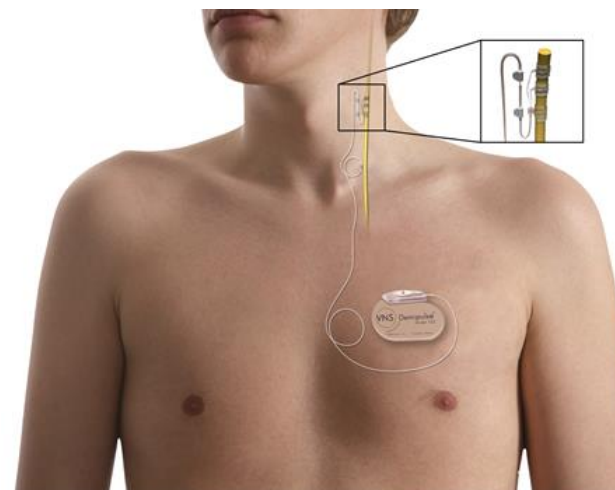
- Målet är anfallsfrihet utan biverkningar. Upp till 70 % blir anfallsfria med behandling
- **Verkningsmekanismen:** minskar deras retbarhet, eller stimulerar dämpande nervimpulser
- **Biverkningar**
 - Icke dosberoende: allergiska utslag, lever och/eller bukspottkörtelpåverkan, benmärgsskada
 - Dosberoende: tex trötthet, synrubbning, ostadighet, illamående.
 - Långtidbiverkningar på vikt, syn, sömn, hormonella rubbningar, osteoporos, psykiska biverkningar.
 - Stor risk för interaktioner
- Risk för fosterskador

Fall 8 – Epilepsi

Anna har till skillnad från Karl inte fått anfallsfrihet med farmakologisk behandling och genomgått kirurgi. Vilka kriterier finns för att kunna vara aktuell för kirurgi vid epilepsi?

Hur påverkas Anna av att leva med epilepsi och hur har det förändrats före respektive efter operationen?

Epilepsi – behandling



<https://www.epilepsi.se/om-epilepsi/behandling/vagusnervstimulering/>

Epilepsi – behandling



- De flesta anfall går över själva
- Om ett anfall inte gått över inom 5 minuter eller vid flera anfall i sträck ges behandling
 - Bensodiazepin (Diazepam) I.V eller klysma
 - Midazolam bucktalt